2.1.3.1. 입퇴실 절차 – 중환자실

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	중환자실운영위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.1.3 중환자실/특수치료실 입실 절차 JCI Standard 7th Edition: ACC.2.3

제1조 (목적)

1. 집중치료가 필요한 환자에게 한정된 자원을 효율적으로 활용하여 적절한 의료서비스를 제공하기 위해 표준화된 중환자실 입퇴실 절차를 준수하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 입실기준: 중환자실 설치 및 운영 목적에 따라, 신체생리적 상태의 악화로 집중 감시와 치료가 요구되는 환자로서 회복 가능성이 있는 고위험 급성 환자군을 대상으로 하며 기준은 아래와 같다.
   1) 심혈관계
      (1) 성인
         ① 급성 관동맥 증후군(심근경색, 불안정형 협심증), 심인성 쇼크, 심부정맥, 심부전 등과 같은 생명을 위협하는 심혈관계 장애
         ② 맥박 40회/분 이하, 맥박 150회/분 이상, 수축기 혈압 80mmHg 이하 등 혈역학적 급성 변화로 집중 감시 및 약물 투여가 요구되는 환자
         ③ 심폐정지가 임박하여 심폐소생술이 예측되거나 심폐소생술로 회복되어 집중 감시가 필요한 환자
      (2) 소아
         ① 심인성 쇼크, 심부정맥, 심부전 등과 같은 생명을 위협하는 심혈관계 장애
         ② 혈역학적으로 불안정하여(맥박 또는 수축기 혈압이 연령별 기준으로 10% 미만) 집중감시 및 약물 투여가 요구되는 환자

연령	맥박(회/분)		수축기 혈압(mmHg)
1주 미만	180 초과	100 미만	65 미만
1주 이상 1개월 미만	180 초과	100 미만	75 미만
1개월 이상 2세 미만	180 초과	90 미만	80 미만
2세 이상 9세 미만	180 초과	60 미만	80 미만

         ③ 심폐정지가 임박하여 심폐소생술이 예측되거나 심폐소생술로 회복되어 집중 감시가 필요한 환자
   2) 호흡기계

(1) 급성 호흡 부전증, 만성 호흡부전 환자, 기도폐쇄 환자
(2) 산소 투여 없이 동맥혈 검사상 PaO2 60mmHg 미만, PaCO2 50mmHg 초과, 산소포화도가 90% 미만 등에 해당하거나 호흡부전으로 지속적인 감시 및 인공호흡기 치료가 필요한 환자

3) 신경계
(1) 신경계 질환이나 손상으로 신경학적 상태가 위중하여 집중적인 감시 및 치료가 필요한 환자
(2) 두부/뇌 또는 척추/척수 수술 또는 중재적 시술 전후 집중적인 감시, 치료 및/또는 인공호흡기 치료가 요구되는 환자
(3) 신경계 질환이나 손상 환자로 내과적 또는 외과적 합병증이 발생하여 집중적인 감시, 치료 및/또는 인공호흡기 치료가 요구되는 환자

4) 신장계
(1) 성인: 소변량이 4시간 동안 50cc 이하로 감소하였거나 신장 기능이 저하되어 지속적 신대체 요법 및 집중적인 감시가 필요한 환자
(2) 소아: 소변량이 4시간 동안 1cc/kg/hr 이하로 감소하거나 신장 기능이 저하되어 지속적 신대체 요법 및 집중적인 감시가 필요한 환자

5) 외과적 수술 및 중재 전 · 후
(1) 수술 후 집중적인 감시 및 인공 호흡기 치료가 필요한 환자
(2) 복잡 병변의 중재적 시술 전 · 후 집중적 감시 및 치료가 요구되는 환자

6) 기타
(1) 약물 중독이나 대사 불균형과 같은 생명에 급격한 위험을 지니고 있는 상태
(2) 다량의 출혈 환자
(3) 다장기 부전 환자 또는 뇌사 장기 공여자

2. 입실 절차
1) 입실기준에 따라 중환자실 의사가 주치의(담당교수)와 상의하여 환자의 입실을 결정한다.
2) 의료진은 입실 시 환자 및 보호자에게 입실 필요성을 설명하고 동의를 받는다.
3) 입실 시점의 환자상태를 평가하고 입실 기준에 합하는지를 의무기록에 기록한다.

3. 퇴실 기준
1) 중환자실 입실 원인인 급성기 상태가 회복된 환자
2) 기도 상태: 스스로 객담 배출이 용이하고 기도유지가 가능한 경우
3) 호흡 상태: 환기 보조 없이 자가 호흡으로 산소포화도가 90 ~ 95% 이상 유지되는 경우
4) 혈역학적 상태: 퇴실 전일의 혈압이 안정적으로 유지되는 경우
(1) 성인: 평균 동맥압 60 mmHg이상
(2) 소아: 수축기 혈압 1개월 이상-12개월 미만 [70mmHg 이상], 1세 이상-10세 미만 [70+(나이×2) mmHg], 10세 이상 [90mmHg 이상]
5) 신경학적 상태: 의식, 신경학적 검사상 호전 소견이 있을 때
6) 급성기 중환자실 치료 이후 더 이상 호전이 없어 중환자실 치료의 필요성이 떨어진다고 주치의(담당교수)가 판단하는 경우 필요 시 호흡보조장치(Ventilator)를 부착한 상태로

병동 전실 또는 타병원으로 이송할 수 있다.

4. 퇴실 절차
   1) 퇴실 기준에 따라 중환자실 의사가 주치의(담당교수)와 상의하여 환자의 퇴실을 결정한다.
   2) 의료진은 퇴실 시 환자 상태를 평가하고 퇴실 기준에 부합하는지를 의무기록에 기록한다.

5. 타병원 중환자실에서 본원 중환자실로 전원 요청이 있을 경우 또는 본원 중환자실에서 타병원 중환자실로 전원 요청이 있을 경우, 중환자실 전담전문의가 환자상태 및 병상상황에 맞추어 전원 시점을 결정한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)